



Consentimiento Informado para Endoscopia Digestiva Alta o Esófago-gastro-duodenoscopia o Panendoscopia oral

Nombre paciente _____

Fecha _____ N° Ficha (RUT) _____ - _____

1. Declaro antes de formular mi consentimiento, que he sido informado sobre la naturaleza de mi enfermedad, su pronóstico y los eventuales daños que ésta produce a sus portadores; sobre las diferentes alternativas de tratamiento clínico que posee la ciencia médica y sobre los beneficios y eventuales riesgos que cada una de ellas conllevan.

2. Declaro además, que he sido informado y se me ha explicado en detalle sobre la naturaleza y fines de la(s) intervención(es) quirúrgica(s) y/o procedimiento(s) a ejecutar, sobre sus alternativas de tratamiento, sobre sus molestias probables, y sobre sus riesgos, daños propios, complicaciones y consecuencias más frecuentes que da cuenta la literatura y la práctica médica. Declaro además que la información antes mencionada, que es actualizada regularmente de acuerdo al conocimiento científico, para cada uno de los procedimientos cuyo consentimiento he dado mediante este instrumento, es la que se agrega a continuación en Anexo Informativo para el paciente y su familia, el que forma parte integrante de este consentimiento. Se me ha informado también que, pese a no encontrarse detalladas en el referido Anexo, existen otras complicaciones posibles que pueden producirse en forma excepcional.

3. Asimismo declaro, que he sido informado sobre los riesgos que enfrente a consecuencia de mi estado previo de salud, de la cual he dado información completa y veraz, de mi edad y otras causas de análoga naturaleza las que acrecientan el riesgo de la(s) intervención(es) quirúrgica(s) y/o procedimiento(s) a ejecutar.

4. Por último declaro que he tenido tiempo suficiente para hacer todas las preguntas que he considerado necesarias para mi mejor comprensión y que he sido informado por el Dr.: _____ y tengo la facultad de revocar este consentimiento sin expresión de causa.

5. Por el presente instrumento, consciente de los riesgos y beneficios de la(s) intervención(es) quirúrgica(s) y/o procedimiento(s) a ejecutar, y habiendo sido informado que el médico responsable de esto es el Dr.: _____, lo autorizo a realizar el procedimiento señalado en el encabezado de este documento.

6. Lo autorizo además a ejecutar la(s) intervención(es) quirúrgica(s) y/o procedimientos complementarios que se deban realizar, dentro de la práctica médica generalmente aceptada y del estándar del establecimiento, en el evento de presentarse complicaciones en la ejecución de la intervención(es) quirúrgica(s) y/o procedimiento(s) autorizados, o con posterioridad, así como en caso de presentarse hallazgos imprevistos durante los mismos.

Firmante: Paciente ☐ Padre/Madre ☐ Apoderado ☐

Nombre del padre o apoderado (si no es el paciente quien firma): _____

RUT N° _____ - _____

Firma del paciente o apoderado

Médico Informante : _____

RUT N° _____ - _____

Firma médico informante

Anexo Informativo para el paciente y su familia

Descripción del procedimiento:

La endoscopia digestiva alta consiste en la visualización del esófago, estómago y primera parte del intestino delgado (duodeno) mediante un tubo flexible con un sistema de iluminación y una cámara (endoscopio), que se introduce a través de la boca. Sirve para el diagnóstico de lesiones situadas en esta zona así como para el tratamiento de algunas de ellas.

La exploración se realiza en una posición cómoda, en una camilla sobre el lado izquierdo. Suele durar 10 - 15 minutos. Durante ese tiempo se puede respirar sin problema por la nariz o por la boca. Se le colocará un protector dental a través del cual se pasará el endoscopio. Para que se tolere mejor se le aplicará un anestésico local en la garganta mediante un pulverizador y se le puede administrar un sedante endovenoso.

Durante la exploración se pueden realizar tratamientos endoscópicos como dilatar zonas estrechas que impiden el paso de los alimentos, extraer objetos tragados y que han quedado atascados, extirpar pólipos, esclerosar o ligar várices esofágicas, aplicar calor a lesiones que pueden ser causa de hemorragia o anemia o destruir con gas argón o láser ciertas lesiones.

Alternativas de tratamiento disponibles:

La alternativa diagnóstica sería una exploración radiológica tras ingerir un medio de contraste para obtener imágenes del tubo digestivo. Sin embargo, permitiría diagnosticar su enfermedad en menor número de casos que la endoscopia, ya que no son posibles la toma de biopsias ni la visualización de lesiones de muy pequeño tamaño. Esta alternativa no podría tratar una hemorragia, ni extirpar un pólipo. Por ello, en algunas ocasiones, incluso tras realizar un estudio radiológico, es necesario realizar una endoscopia digestiva alta.

La cápsula endoscópica (pequeña cámara que se traga) no sustituye tampoco a la endoscopia digestiva alta, por razones parecidas.

En ocasiones la alternativa al tratamiento endoscópico suele ser una intervención quirúrgica que supone más riesgos y complicaciones.

Proceso previsible durante y después del procedimiento:

La tolerancia es variable de un enfermo a otro, pero no provoca dolor ni dificulta la respiración normal. Puede ocasionar discreto malestar en el abdomen y náuseas, que generalmente desaparecen rápidamente. Puede quedar alguna molestia menor en la garganta que desaparece horas después, como también meteorismo o gases debido al aire que se le insufló. Si se ha administrado sedante intravenoso, puede quedar cierta sedación residual durante varias horas.

Riesgos del procedimiento:

Cualquier actuación médica tiene riesgos. La mayor parte de las veces los riesgos no se materializan, y la intervención no produce daños o efectos secundarios indeseables. Pero a veces no es así. Por eso es importante que usted conozca los riesgos que pueden aparecer en este proceso o intervención.

Riesgos Frecuentes: La endoscopia digestiva alta es una técnica muy segura. La mayoría de las complicaciones son leves y sin repercusión alguna, como las producidas por reacciones no deseadas a la medicación administrada. La posibilidad de complicaciones es mayor cuando el endoscopio se emplea para aplicar tratamientos, como dilataciones, polipectomías, ligadura de várices o extracción de cuerpos extraños. Otras complicaciones menores son:

1. Roturas dentales
2. Mordedura de lengua.
3. Luxaciones mandibulares o disfonía.



Riesgos Graves: Entre las complicaciones mayores están

1. perforación
2. Hemorragia.
3. Reacciones alérgicas medicamentosas.
4. Alteraciones cardiopulmonares y transmisión de infecciones. Como consecuencia de alguna de estas complicaciones, excepcionalmente puede ser necesario hospitalización, algún tratamiento urgente o una operación.

Otros derivados de su problema de salud, de su edad o condición personal (a completar por el médico):

.....

Otras informaciones de interés:

Alergias a medicamentos: Debe conocerse previamente si hay alergia a anestésicos o sedantes a fin de evitar su empleo si están contraindicados.

Enfermos con tratamiento antiagregante o anticoagulante pueden tener más riesgo de hemorragia, sobre todo si se toman biopsias. Se deben tomar precauciones al respecto.

La insuficiencia cardíaca, la insuficiencia respiratoria y el infarto agudo de miocardio reciente incrementan el riesgo de complicaciones.

Para tener un buen rendimiento debe estar en ayunas 8 horas antes .Avisa si padece posibles alergias a medicamentos.

Notifique también con tiempo (al menos una semana antes) si toma algún medicamento anticoagulante o antiagregante (aspirina, Neosintrom, Xarelto, Tromalyt, Iscover), ya que puede ser necesario suspenderlos antes. Retire su prótesis dentaria, si la tiene.

Acuda acompañado. No coma ni beba nada en la hora y media siguiente.

No conduzca vehículos el resto del día si se le ha administrado sedación.

A veces, durante la intervención, se producen hallazgos imprevistos. Pueden obligar a tener que modificar la forma de hacer la intervención y utilizar variantes de la misma no contempladas inicialmente.

A veces es necesario tomar muestras biológicas o biopsias para estudiar mejor su caso. Pueden ser conservadas y utilizadas posteriormente para realizar investigaciones relacionadas con la enfermedad que usted padece. No se usarán directamente para fines comerciales. También puede ser necesario documentar el caso clínico con imágenes (fotos o videos) para usarse con fines docentes de difusión del conocimiento científico. Su identidad siempre será preservada de forma confidencial.

RUT N° _____ - _____

Firma paciente